

Spektrum *hazardu*

Od rekreacji do patologii — cztery poziomy z różnymi interwencjami. Wczesny etap to nie „nic”, to moment, w którym pomoc działa najsilniej.

CZAS: 20 min Skala oceny + plan **ŹRÓDŁO:** DSM-5; Blaszczyński & Nower (2002)

JAK UŻYWAĆ

1 · Oceń swój poziom zaangażowania na 4-stopniowej skali (sekcja 01). **2** · Sprawdź kryteria DSM-5 (sekcja 02) — policz, ile z dziewięciu rozpoznajesz u siebie. **3** · Zidentyfikuj swój typ gracza wg modelu ścieżek Blaszczyńskiego (sekcja 03) — bo inne typy wymagają innego leczenia. **4** · Odpowiedz uczciwie na pytanie o *odgrywanie się* — to najsilniejszy predyktor eskalacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zaburzenie hazardowe (ICD-11 6C50, DSM-5) dotyka 0,5–2% dorosłych (Williams 2012), a kolejne 3–5% to gracze problemowi (zagrożeni). Wczesna interwencja jest *nieporównywalnie* skuteczniejsza — etapy 1–2 często odpowiadają na samą psychoedukację i krótką interwencję (BI). Etap 3 wymaga już formalnej terapii, etap 4 — interwencji wielomodalnej (terapia + finanse + rodzina). Blaszczyński i Nower (2002) w modelu ścieżek (ang. *Pathways Model*) pokazali, że **trzy typy graczy** wymagają trzech różnych podejść — leczenie dopasowane do typu daje znacznie wyższą skuteczność niż protokoły jednolite. Klucz: *kasyna nie zarabiają na pierwszych wizytach* — zarabiają na chasingu, czyli na próbach odgrania strat. Każde pytanie diagnostyczne, które wykluczy chasing, jest oszczędne klinicznie.

01 📋 Cztery poziomy zaangażowania w hazard

1 · REKREACJA

75% dorosłych raz w roku

Lotek, urodzinowa wizyta w kasynie, okazjonalny zakład. Kwota planowana z góry, czas ograniczony, koniec gry nie boli. *Brak interwencji* — psychoedukacja profilaktyczna.

2 · RYZYKOWNE

PGSI 1–2 punkty

Częściej niż planowane, czasem ponad budżet. Sporadyczne kłopoty (kłamstwo, spóźnienie). Brak strat trwałych. *Psychoedukacja, samoograniczenie, monitoring.*

3 · PROBLEMOWE

PGSI 3–7 punktów

Regularne tracenie pieniędzy ponad możliwości. Konflikty rodzinne. Pierwsze próby ograniczenia bezskuteczne. *Krótką interwencją motywującą (BI) + CBT.*

4 · PATOLOGICZNE

PGSI 8+, DSM-5: 4+ kryteria

Zaburzenie hazardowe (DSM-5/ICD-11). Zadłużenie, kradzieże, kłamstwa, ryzyko utraty pracy i bliskich, myśli samobójcze. *Terapia + finanse + rodzina + ew. farmakoterapia.*

02 🕒 Kryteria DSM-5 — policz, ile rozpoznajesz

Zaznacz te, które dotyczą Twoich ostatnich 12 miesięcy. **4–5** = łagodne, **6–7** = umiarkowane, **8–9** = ciężkie zaburzenie hazardowe.

- ☐ **1 · Tolerancja** — potrzeba grania o coraz wyższe stawki, żeby osiągnąć ten sam poziom pobudzenia
- ☐ **2 · Niepokój** — drażliwość lub niepokój przy próbach ograniczenia/przerwania grania
- ☐ **3 · Bezskuteczne próby** — wielokrotne próby kontroli, ograniczenia lub zaprzestania grania, które się nie powiodły
- ☐ **4 · Myśli pochłaniające** — częste myślenie o hazardzie (przeżywanie wygranych, planowanie kolejnych zakładów, sposoby zdobycia pieniędzy)
- ☐ **5 · Regulacja emocji** — granie w odpowiedzi na trudne uczucia (lęk, smutek, samotność, bezradność)
- ☐ **6 · Odgrywanie się** — po przegranej powracanie innego dnia, żeby „odzyskać straty” (ang. *chasing*)
- ☐ **7 · Kłamstwa** — okłamywanie najbliższych co do skali grania
- ☐ **8 · Straty relacyjne / zawodowe** — utrata związku, pracy, możliwości edukacyjnej z powodu hazardu
- ☐ **9 · Pożyczanie** — zwracanie się do innych o pieniądze, by wyjść z trudnej sytuacji finansowej spowodowanej hazardem

03 Trzy typy graczy — model ścieżek Blaszczynskiego

Blaszczynski i Nower (2002) wykazali, że za hazardem patologicznym stoją **trzy różne mechanizmy**. Każdy wymaga innego leczenia. Sprawdź, który jest u Ciebie dominujący.

TYP 1 · BEHAWIORALNIE UWARUNKOWANY

najlepsze rokowanie

„Zaczęło się towarzysko — jakoś wciągnęło.” Bez psychopatologii, bez traumy. Hazard jako wyuczony nawyk. **Leczenie:** CBT, psychoedukacja, samoograniczenie. Często krótka interwencja wystarcza.

TYP 2 · EMOCJONALNIE WRAŻLIWY

średnie rokowanie

„Gram, żeby zapomnieć.”
Współwystępująca depresja, lęk lub trauma. Hazard jako ucieczka.
Leczenie: CBT hazardu *plus* terapia podstawowego zaburzenia (depresji, PTSD, lęku).

TYP 3 · IMPULSYWNY

najtrudniejsze leczenie

Silna impulsywność, poszukiwanie wrażeń, często konflikty z prawem, cechy antyspołeczne.
Leczenie: struktura, długotrwała terapia, czasem farmakoterapia (naltrekson). Konieczna stabilizacja zewnętrzna.

04 Moja sytuacja — autorefleksja

MÓJ POZIOM Z SEKCJI 01

— 1, 2, 3 czy 4

LICZBA KRYTERIÓW DSM-5 Z SEKCJI 02

MÓJ TYP WG BLASZCZYNŚKIEGO

— 1, 2 czy 3, z uzasadnieniem

PYTANIE KLUCZOWE

— czy po przegranej wracam, żeby się odegrać? (chasing)

Klucz: jeśli odpowiedź na pytanie o *odgrywanie się* brzmi „tak” — jesteś już *poza* rekreacją, niezależnie od ilości pieniędzy. Chasing to **najsilniejszy predyktor eskalacji** (Blaszczynski 2002) — i jednocześnie mechanizm, na którym kasyna zarabiają. Każda próba „odegrania” pogłębia straty, bo prawdopodobieństwa nie zależą od historii. Wskaźnik samobójstw u osób z hazardem patologicznym jest **5-10x wyższy** niż w populacji ogólnej (Moghaddam i wsp. 2015) — wczesna interwencja ratuje życie, nie tylko finanse.